示例病历

口腔临床病历 1：林某

就诊日期： 2023 年 10 月 26 日

就诊科室： 口腔美容科

病历号： MK20231026018

患者基本信息：

姓名： 林某

性别： 女

年龄： 32 岁

职业： 外企项目经理

联系电话： 138-XXXX-XXXX

首次就诊： 是

主诉：

上前牙颜色偏黄，影响美观，要求美白治疗 3 月余。

现病史：

患者约 3 年前开始自觉上前牙颜色逐渐加深，呈暗黄色。自述因工作原因，长期有饮用咖啡、茶及可乐的习惯（每日约 2-3 杯美式咖啡，有饮浓茶习惯，偶尔饮用可乐）。曾尝试使用美白牙

膏，效果不显。近期因社交活动增多，自觉微笑时牙齿颜色影响个人形象，故来我院寻求专业美白治疗。无自发痛、冷热刺激痛及咬合不适。今至我科，要求行“冷光美白”治疗。

既往史：

全身情况： 平素体健。否认高血压、糖尿病、心脏病等系统性疾病史。否认肝炎、结核等传染病史。

过敏史： 否认药物、食物及其他过敏史。

口腔治疗史： 既往有定期洁牙史，无正畸、修复治疗史。否认牙外伤史。

检查：

口外检查： 面部对称，开口度及开口型正常，颞下颌关节未及弹响及压痛。

口内检查：

全口卫生状况： 可，软垢（+），色素（+）。

牙体情况： 全口牙列完整，未见明显龋坏及缺损。11、12、21、22 牙冠颜色暗黄，色泽不均，以 11、21 为著。 牙体硬组织完整，未探及龋坏及缺损，探诊（-），冷试（-），热试（-），叩诊（-）。

牙周情况： 牙龈颜色、形态、质地基本正常，探诊深度普遍 2-3mm，探诊出血（BOP）阴性，未及附着丧失。牙齿松动度（-）。

比色： 使用 VITA Classical 比色板于自然光下比色，11、21 牙冠中 1/3 色值约为 C2，12、22 牙冠中 1/3 色值约为 C1。

辅助检查：

口内数码照片（术前）：记录上前牙唇面观、微笑像。

（必要时可补充）X 线片检查：患者无主诉不适，且临床检查未见异常，暂未行 X 线检查。

诊断：

黄染牙（外源性染色为主）

诊断编码： K00.8（根据 ICD-10，其他特指的牙齿发育障碍）

治疗方案：

行 Beyond 冷光美白术，改善上前牙美学外观。

术前向患者详细说明治疗流程、预期效果、可能出现的术后敏感等风险及术后维护注意事项，患者表示理解并签署《冷光美白治疗知情同意书》。

处置（治疗记录）：

术前准备： 再次与患者确认治疗意愿及知情同意。术前使用 VITA 比色板精确比色并记录为 C2。拍摄术前口内标准照及微笑像存档。

牙面清洁： 使用不含氟的抛光膏对全口牙面进行彻底抛光，去除表面软垢及外源性色素，漱口清洁。

隔离与保护： 涂抹唇油，放置开口器。隔湿棉卷隔离，三用枪彻底吹干治疗牙位（11、12、21、22）唇侧面。

牙龈保护： 在龈缘 0.5mm 范围内均匀涂抹光固化树脂型牙龈保护剂，使用光固化灯照射固化 3-4 秒，形成完整保护屏障。

美白治疗：

第一轮：在牙面唇侧均匀涂抹约 2mm 厚度的 Beyond 冷光美白凝胶（主要成分：过氧化氢）。调整 Beyond 美白仪照射头距离牙面约 1cm，进行持续 8 分钟的冷光照射。过程中患者无不适。

移除凝胶：8 分钟后，使用强吸唾器彻底吸除牙面所有美白凝胶，注意避免污染软组织。

第二轮：重复步骤 5（涂抹凝胶 - 照射 8 分钟 - 吸除）。

第三轮：重复步骤 5（涂抹凝胶 - 照射 8 分钟 - 吸除）。

术后处理： 治疗结束后，嘱患者彻底漱口。去除牙龈保护剂及开口器。使用三用枪吹干牙面。

效果评估： 术后即刻于相同光线条件下比色，牙冠色值提升至 A1。拍摄术后口内标准照及微笑像存档。患者对即刻美白效果表示满意。

术后医嘱：

告知术后 24-48 小时内可能出现牙齿短暂敏感，属正常反应，通常可自行缓解，必要时可使用抗敏感牙膏。

“白色饮食”建议： 术后 24-48 小时内避免食用或饮用任何可能染色的食物及饮料，如咖啡、茶、红酒、可乐、酱油、咖喱、莓果等。建议饮用清水、牛奶，食用米饭、面条、鱼肉、鸡肉（白肉）、香蕉、苹果（去皮）等。

建议使用软毛牙刷及抗敏感牙膏刷牙。

告知美白效果非永久性，通常可维持 1-2 年，其持久度与个人饮食习惯及口腔维护密切相关。建议定期洁治（每 6-12 个月一次）。

预约 1 周后复查，评估效果及有无不适。

医师签名： A 陈医生

日期： 2023 年 10 月 26 日

口腔临床病历 2：王毛毛

儿童龋齿充填治疗

就诊日期： 2023 年 11 月 15 日

就诊科室： 儿童口腔科

病历号： CP20231115007

患者基本信息：

- **姓名：** 王某某（儿童）
- **性别：** 男
- **年龄：** 8 岁
- **陪同人员：** 母亲李女士
- **联系电话：** 139-XXXX-XXXX
- **首次就诊：** 是

主诉：

右上后方牙齿容易塞进食物 1 周。

现病史：

患儿母亲代诉，约 1 周前，患儿在进食肉类（如瘦肉丝）后感觉右上后方牙齿缝隙容易卡住食物，需用牙签或用力漱口才能清除，自述无自发疼痛、冷热刺激痛及夜间痛。未自行用药。为求进一步诊治，今由家长陪同来我院。患儿平日喜食甜食，刷牙每日早晚各一次，但家长监督不够严格。

既往史：

- **全身情况：** 体健。否认哮喘、癫痫、先天性心脏病等全身系统性疾病史。否认传染病史。
- **过敏史：** 否认药物、食物过敏史。
- **口腔治疗史：** 既往有涂氟史，无充填、拔牙等治疗史。

检查：

- **口外检查：** 面部对称，颌面部发育正常，双侧颞下颌关节未及异常。
- **口内检查：**

- **口腔卫生：** 一般，可见软垢及少量色素附着。
- **患牙检查（16）：** 16（右上第一恒磨牙）远中邻颌面可见一褐色龋洞，洞壁有腐质，洞深未及牙髓。探诊洞底质硬，无疼痛（-），未探及穿髓孔。冷试（-），热试（-）。叩诊（-），垂直及水平向叩诊均无不适。牙齿无松动（-）。颊侧牙龈乳头轻度充血，探诊无出血。
- **邻牙及对颌牙检查：** 15、17 未见明显异常，36、46 已萌出，颌面窝沟深。
- **电活力测试：** 16 牙髓活力测试读数与正常对照牙（26）相似，提示牙髓活力正常（+）。

辅助检查：

- 口内数码照片：记录 16 牙龋坏情况。
- （口内 X 线片建议：可拍摄咬合翼片以评估邻面龋坏深度及与髓腔关系，但根据临床检查已明确为中龋，且患儿配合度一般，本次暂未拍摄。）

诊断：

16 中龋

诊断编码： K02.1（牙本质龋）

治疗方案：

行 16 牙树脂充填术。向患儿家长详细解释病情、治疗必要性、步骤、费用及预后（充填物可能脱落、继发龋等），家长表示理解并签署《治疗知情同意书》。

处置（治疗记录）：

1. **术前沟通与准备：** 与患儿进行轻松交流，减轻其紧张情绪。使用菌斑显示剂指导刷牙，强调窝沟清洁重要性。
2. **麻醉与隔湿：** 因龋坏较深，为保障治疗无痛，于 16 颊侧黏膜行局部浸润麻醉（使用阿替卡因肾上腺素注射液，剂量按体重计算）。麻醉生效后，安置橡皮障，有效隔湿并保护软组织。
3. **去龋备洞：** 使用高速涡轮手机配合车针去除 16 远中邻颌面龋坏组织，去净腐质，形成合规的 II 类洞形。过程中确保未露髓。
4. **洞衬与粘接：** 洞底近髓处涂布一层玻璃离子水门汀作为护髓垫底。随后依次使用酸蚀剂酸蚀牙面、冲洗、吹干、涂布粘接剂、光照固化。
5. **树脂充填与塑形：** 选择颜色匹配的纳米树脂材料，采用斜分层填充技术逐层填入窝洞，每层厚度不超过 2mm，并使用光固化灯分层照射固化。恢复牙齿正常的邻接关系及颌面解剖形态。
6. **调颌与抛光：** 去除橡皮障。使用咬合纸检查咬合，调整充填体高点至无早接触。使用金刚砂抛光车针及抛光碟对充填体进行精细抛光，恢复光滑表面。
7. **术后医嘱（已向家长及患儿交代）：**

- 麻药消退约需 **2 小时**，期间请勿咬嘴唇、颊侧黏膜，防止自伤。**2 小时内勿用右侧咀嚼。**
- **24 小时后**，充填材料完全固化，可恢复正常双侧咀嚼。
- 如出现轻微不适可观察，若出现自发痛、咬合痛加剧或充填物脱落等情况，请及时复诊。
- 加强口腔卫生，使用牙线清洁邻面，控制甜食摄入频率，建议定期（每 3-6 个月）复查并进行窝沟封闭。

医师签名： A 陈医生

日期： 2023 年 11 月 15 日

口腔临床病历 3：张某

成人牙髓炎综合治疗

就诊日期： 2023 年 12 月 5 日

就诊科室： 牙体牙髓科 / 口腔综合科

病历号： AD20231205022

患者基本信息：

- **姓名：** 张某
- **性别：** 男
- **年龄：** 45 岁
- **职业：** 公司职员
- **联系电话：** 137-XXXX-XXXX
- **首次就诊：** 是

主诉：

左上后牙阵发性疼痛数日。

现病史：

患者自述左上后牙区域近几日出现阵发性、自发性钝痛，夜间平卧时疼痛略有加重，冷热刺激可诱发或加剧疼痛，无明确放射痛。疼痛影响进食与睡眠。曾自行服用止痛药（具体不详），效果不佳。今为求系统治疗来我院。患者口内有多处既往治疗痕迹。

既往史：

- **全身情况：** 平素体健，否认高血压、糖尿病、心脏病史。否认传染病史。
- **过敏史：** 否认药物及材料过敏史。

- **口腔治疗史：** 多年前于外院行左下后牙“抽神经”治疗（具体牙位不详），后未行冠修复。右上后牙曾行烤瓷冠修复。口腔卫生习惯一般。

检查：

- **口外检查：** 面部对称，未及肿胀，开口度正常，颞下颌关节无异常。
- **口内检查：**
  - **口腔卫生：** 一般，牙石（+），色素（+）。
  - **患牙检查（26）：** 26（左上第一恒磨牙）颌面可见深大龋洞，洞内大量食物残渣及软化腐质，探诊洞底敏感（+），有探痛，未探及明确穿髓孔但已近髓。冷试敏感且疼痛持续数秒。叩诊轻微不适（±）。牙齿无松动。颊侧牙龈无明显红肿。
  - **其他问题牙检查：**
    - **27：** 牙冠大面积缺损，仅残留部分牙根于龈上，断面平龈，探诊无痛，叩诊（-），无松动，诊断为**残根**。
    - **16：** 可见**金属烤瓷全冠修复体**，边缘尚可，叩诊（-），无松动。
    - **36/37 区域：** 36（左下第一恒磨牙）颌面可见**暂封物**，叩诊（-），无松动。据患者回忆为“根管治疗后未做牙冠”。

辅助检查：

- 根尖片 /X 线全景片：显示 26 颌面低密度影近髓腔，根尖周膜影像基本正常。27 残根，根尖无明显阴影。36 根管内可见高密度充填影像，根充可，根尖周未见明显异常。

诊断：

1. **26 慢性牙髓炎（急性发作）**

   诊断编码： K04.01

1. **27 残根**

   诊断编码： K08.3

2. **36 牙体缺损（根管治疗后）**

   诊断编码： K08.1

3. **16 烤瓷冠修复后**

治疗方案：

向患者详细解释病情及以下综合治疗计划，患者知情同意并签署相关同意书。

4. **针对 26：** 试行**根管治疗术（RCT）**，保留患牙。告知若治疗过程中发现根管钙化不通、器械分离或根尖周病变过大等意外情况，可能需调整方案（如根尖手术或拔除）。
5. **针对 27：** 建议**拔除**。解释残根无保留价值，且可能成为感染病灶或影响邻牙健康。
6. **针对 36：** 建议**全瓷冠修复**。解释根管治疗后牙齿脆性增加，需行冠修复以防牙体折裂。

7. **治疗顺序：** 先处理急性症状（26 的根管治疗），同期或择期拔除 27，最后完成 36 的永久修复。

处置（治疗记录）：

本次就诊（处理 26 急性症状）：

8. **麻醉与隔湿：** 必兰麻行 26 颊腭侧局部浸润麻醉，麻醉生效后，安置橡皮障。
9. **开髓与揭顶：** 去除 26 颌面腐质及软化牙本质，用高速球钻揭开髓室顶，可见冠髓部分坏死，有渗血。
10. **髓腔处理与封药：** 初步清理髓腔，用锐利挖匙去除冠部坏死牙髓。因患者时间有限，且出血较多，决定行**牙髓失活**。于各根管口放置适量**多聚甲醛失活剂**，上置**丁香油酚棉球**安抚，最后用**氧化锌丁香油水门汀（ZOE）** 严密暂封。
11. **医嘱：** 告知封药后可能有轻微胀痛属正常反应，约 **7-10 天后**复诊进行下一步根管清理。若出现剧烈肿痛及时联系。预约复诊时间。

其他治疗安排（记录于治疗计划中）：

- **27 拔除：** 拟于 26 症状缓解后或下次复诊时，行**局部麻醉下微创拔除术**，术后压迫止血。
- **36 全瓷冠修复：** 拟于 26 根管治疗完成后，进行 36 的**牙体预备、取模、制作并戴入全瓷冠**。本次先制取研究模型。
- **口腔卫生指导：** 给予巴氏刷牙法及牙线使用指导，建议全口洁治。

医师签名： A 李医生

日期： 2023 年 12 月 5 日